

Fístulas gastrointestinales

1. Introducción y relevancia clínica

Una **fístula gastrointestinal** es una **comunicación anormal entre el tracto digestivo y otra estructura** (órgano, piel, cavidad o superficie corporal), que permite la salida de contenido gastrointestinal.

Son una **complicación grave del postoperatorio abdominal** y de enfermedades inflamatorias intestinales, con **alta morbilidad y mortalidad (hasta 30%)**, principalmente por **sepsis, desnutrición e hidroelectrolitos**.

En Chile, las causas más frecuentes son:

- **Complicaciones postquirúrgicas (70–80%)**, sobre todo tras cirugía de colon o estómago.
 - **Enfermedades inflamatorias** como Crohn o diverticulitis.
 - **Trauma abdominal penetrante**.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Mecanismo de formación

1. **Daño o dehiscencia de una anastomosis o pared intestinal.**
 2. **Escape de contenido digestivo** hacia cavidad o piel.
 3. **Inflamación y necrosis local** que perpetúan el trayecto fistuloso.
 4. Si no se controla el flujo → **persistencia crónica y pérdida de fluidos, electrolitos y proteínas.**
-

2.2 Clasificación anatómica

Tipo de fístula	Descripción
Externa	Comunica el tubo digestivo con la piel (enterocutánea).
Interna	Comunica dos vísceras (enteroentérica, colovesical, gastrocolónica).
Mixta	Tiene componente interno y externo.

2.3 Clasificación según localización

Localización	Frecuencia	Características
Gástrica / duodenal	10–20%	Alto débito, pérdida de HCl, hipocloremia, alcalosis metabólica
Yeyunal	30%	Pérdida masiva de líquidos y proteínas
Íleal	20%	Riesgo de sepsis y acidosis metabólica
Colónica	30%	Contaminación fecal severa, sepsis

2.4 Clasificación según débito

Tipo	Débito diario	Pronóstico
------	---------------	------------

Alto débito >500 mL/día Peor

Bajo débito <200 mL/día Mejor

Moderado 200–500 mL/día Intermedio

El **débito y la localización** son los principales factores pronósticos:

- Fístulas de intestino delgado → más graves.
 - Fístulas colónicas → más infecciosas.
-

2.5 Factores que impiden el cierre espontáneo (“FRIEND”)

Foreign body (cuerpo extraño)

Radiation (irradiación previa)

Infection / Inflammation persistente

Epithelialization (trayecto maduro)

Neoplasm

Distal obstruction (obstrucción distal)

Si alguno de estos factores está presente → bajo potencial de cierre espontáneo.

3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1 Manifestaciones clínicas generales

- Salida de contenido intestinal por herida quirúrgica o drenaje.
- Fiebre, taquicardia, signos de sepsis.
- Deshidratación y desequilibrio hidroelectrolítico.
- Distensión abdominal, íleo, dolor.
- Pérdida de peso rápida y desnutrición proteica.

3.2 Características del débito según localización

Origen	Tipo de líquido	Alteraciones metabólicas
Gástrico	Verdoso, ácido	Alcalosis metabólica
Duodenal / yeyunal	Amarillo, bilioso	Pérdida de sodio, potasio, bicarbonato
Íleal	Marrón, fétido	Acidosis metabólica
Colónico	Fecaloide	Sepsis y mal olor

3.3 Diagnóstico diferencial

Cuadro	Diferencia clave
Absceso intraabdominal	No hay exteriorización de contenido intestinal
Dehiscencia anastomótica sin fístula	Fiebre, dolor, líquido seropurulento sin bilis o heces
Fístula biliar / pancreática	Localización alta, líquido claro o enzimático

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Laboratorio

- Hemograma: leucocitosis, anemia.

- Electrolitos: hiponatremia, hipocloremia, hipopotasemia.
 - Proteínas plasmáticas: hipoalbuminemia.
 - PCR y procalcitonina (sepsis).
 - Balanza de líquidos estricta.
-

4.2 Imágenes

- **TAC abdominopélvico con contraste oral y EV:**
 - Localiza el origen y trayecto fistuloso.
 - Detecta abscesos asociados u obstrucción distal.
- **Fistulografía (radiografía con contraste hidrosoluble):**
 - Define trayecto y comunicación con tubo digestivo.
- **Endoscopía o colonoscopia:**
 - En fístulas internas o recidivantes.

□ *Nunca usar bario en fistulografía (riesgo de peritonitis).*

4.3 Diagnóstico

Clínico-radiológico: salida de contenido digestivo + evidencia imagenológica del trayecto.

5. Tratamiento (según guías WSES / MINSAL / ASPEN)

5.1 Objetivos

1. Control de sepsis.
2. Reposición hidroelectrolítica.
3. Nutrición adecuada.

4. Control del débito y protección de la piel.
5. Cierre espontáneo o quirúrgico si falla.

5.2 Manejo médico inicial (“Regla de las 4 S”)

Sepsis control

Suministro (nutrición)

Solución de electrolitos

Salida controlada (manejo del débito)

A. Control de sepsis

- **Antibióticos de amplio espectro:**
 - *Piperacilina/tazobactam, meropenem, o ceftriaxona + metronidazol.*
 - **Drenaje de abscesos** (percutáneo o quirúrgico).
 - **TAC de control** para descartar colecciones residuales.
-

B. Reposición de volumen y electrolitos

- Suero fisiológico o Ringer lactato.
 - Suplementar sodio, potasio, cloro y bicarbonato.
 - Corrección de acidosis o alcalosis según tipo de fístula.
-

C. Control del débito

- **Somatostatina o octreótido (50–100 µg c/8h):** reduce secreciones intestinales.
- **Aspiración con sonda nasogástrica.**
- **Cierre parcial del orificio externo** (no oclusivo).

- **Protección cutánea** con barreras (pasta de óxido de zinc, colectores especiales).
-

D. Nutrición

- **Fundamental para cierre espontáneo.**
 - **Nutrición parenteral total (NPT)** inicial en fístulas de alto débito.
 - **Nutrición enteral distal** (si posible) favorece trofismo intestinal.
 - **Objetivo:** 30–35 kcal/kg/día y 1,5–2 g proteína/kg/día.
-

E. Cirugía

Solo si el manejo médico falla (tras 6–8 semanas) o hay factores “FRIEND”.

Indicaciones quirúrgicas:

- Fístula persistente >2 meses sin tendencia al cierre.
- Obstrucción distal o cuerpo extraño.
- Neoplasia o enfermedad inflamatoria persistente.
- Drenaje no controlado o sepsis recurrente.
- Deterioro nutricional progresivo.

Técnica quirúrgica:

- **Resección del segmento afectado + anastomosis primaria.**
 - Cierre de trayecto fistuloso.
 - En casos graves: **ostomía de derivación** temporal.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Consecuencia
Sepsis	Principal causa de muerte
Desnutrición severa	Retarda cicatrización
Desequilibrio hidroelectrolítico	Hipovolemia, falla renal
Erosión cutánea	Por efluente digestivo
Mortalidad	10–30%, depende de localización y sepsis

Pronóstico:

- Fístulas de bajo débito → 70–80% cierran espontáneamente.
- Fístulas de alto débito → 20–30% cierran sin cirugía.
- El cierre espontáneo ocurre en promedio a las **4–6 semanas**.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. Toda **fístula postoperatoria** debe considerarse **séptica hasta demostrar lo contrario**.
2. La **sepsis y la desnutrición** son los principales enemigos del cierre.
3. **Octreótido** disminuye el débito y favorece el cierre.

4. **Nutrición parenteral temprana** mejora la supervivencia.
 5. El **TAC con contraste** es el examen diagnóstico más útil.
 6. El **cierre espontáneo** es posible si no hay obstrucción ni factores "FRIEND".
 7. **Cirugía diferida**: nunca operar una fístula séptica activa.
-



Errores comunes

- No reanimar al paciente antes de estudiar la fístula.
 - Administrar líquidos sin reponer electrolitos.
 - Cerrar precozmente la fístula sin resolver sepsis.
 - Omitir la nutrición parenteral.
 - Realizar cirugía en fase inflamatoria (fracaso casi seguro).
 - Usar bario como contraste en fistulografía.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Fístula gastrointestinal = comunicación anormal del tubo digestivo.**
2. **Causa más frecuente:** complicación postquirúrgica abdominal.
3. **Debido al alto débito y sepsis**, requiere manejo intensivo multidisciplinario.
4. **Tratamiento inicial:** control de sepsis, fluidos, electrolitos, nutrición, octreótido.
5. **Cierre espontáneo** posible si no hay factores "FRIEND".
6. **Cirugía diferida** solo tras estabilización y fallo del manejo médico.
7. **Mortalidad elevada**, pero prevenible con control temprano de sepsis y soporte nutricional.